

Отведение мочи — Сравнение вариантов

Информация для пациента · Три способа отвести мочу при удалённом или нефункционирующем мочевом пузыре

WARWIKI

Когда мочевой пузырь удалён или перестал работать, моче нужен новый путь из организма — это называется отведением мочи. Существуют три основных вида. Все используют фрагмент собственного кишечника и различаются главным образом тем, **как вы опорожняете мочу каждый день**: через мешок на животе, через уретру или с помощью катетера. Этот листок сравнивает все три варианта; у каждого есть и отдельный подробный листок.

Три варианта

НОШЕНИЕ МЕШКА

Ileal Conduit (кишечный конduit)

Короткий участок кишечника выводит мочу на переднюю стенку живота через небольшое отверстие (**стома**), откуда она постоянно стекает в лёгкий **мешок**, который вы опустошаете и меняете. Самый простой и распространённый вариант: ничего не надо контролировать или катетеризировать.

МОЧЕИСПУСКАНИЕ ЧЕРЕЗ УРЕТРУ · БЕЗ МЕШКА

Ортотопический неомочевой пузырь

Новый резервуар из кишечника соединяется с **уретрой**, и вы мочитесь привычным способом без мешка. Вы учитесь опорожнять его по **расписанию** (днём и ночью), иногда может потребоваться катетер; поначалу возможно подтекание.

ОПОРОЖНЕНИЕ КАТЕТЕРОМ · БЕЗ МЕШКА

Континентное кожное отведение (Indiana Pouch)

Внутренний резервуар из кишечника накапливает мочу, а небольшое герметичное отверстие (обычно в **пупке**) остаётся сухим. Мешок не нужен — вы вводите **катетер** через это отверстие несколько раз в день.

ТЕРМИНЫ

Отведение мочи

Новый путь для мочи из организма, когда мочевой пузырь отсутствует или не работает.

Стома

Небольшое отверстие на коже из кишечной ткани, через которое выходит моча.

Конduit

Короткий участок кишечника, проводящий мочу к стоме (не накапливает её).

Неомочевой пузырь

Новый мочевой пузырь из кишечника, соединённый с уретрой.

Континентное

Герметичное — вы сами управляете опорожнением.

Инконтинентное отведение

Постоянное дренирование в мешок (кишечный conduit).

Катетеризировать

Ввести тонкую трубку для отведения мочи.

Слизь

Жидкость, которую вырабатывает кишечник; нити слизи в моче после любого отведения — норма.

КАК ВЫБРАТЬ ПОДХОДЯЩИЙ ВАРИАНТ? Оптимальный выбор зависит от вашей анатомии, функции почек, общего состояния здоровья, а также от силы рук и остроты зрения (необходимы для катетеризации) — и от вашего образа жизни и личных приоритетов. Не каждый подходит для любого варианта. Хирург скажет вам, какие из них безопасны именно для вас.

Сравнение вариантов

	Ileal Conduit	Неомочевой пузырь	Континентное (Indiana)
Способ опорожнения	Самопроизвольно	Мочеиспускание через уретру	Катетер через стоу
Нужен мешок?	Да	Нет	Нет
Нужен катетер?	Нет	Иногда	Всегда, каждые 4–6 ч
Объём операции	Наименьший	Большой	Большой
Ежедневный уход	Опустошать и менять мешок	Плановое мочеиспускание днём и ночью	Катетеризация и промывание

Общее для всех трёх вариантов

- Используется участок **собственного кишечника**, поэтому после операции кишечнику нужно несколько дней для восстановления.
- **Слизь** в моче — норма: её вырабатывает кишечник.
- Необходимо **пожизненное наблюдение**, включая контроль уровня **витамина B12** (кишечный сегмент может снижать его со временем).
- **Пейте достаточно жидкости**, чтобы промывать мочевые пути.

Вопросы хирургу

- Какие варианты мне **подходят** и какой вы рекомендуете?
- Как будет выглядеть **повседневная жизнь** и самопомощь при каждом?
- Как это повлияет на **работу, спорт, сон и интимную жизнь**?
- Каковы основные **риски** и вероятность повторного вмешательства?

ТРИ ВАЖНЫХ МОМЕНТА

1. Есть три способа отвести мочу — **мешок** (ileal conduit), мочеиспускание через **уретру** (неомочевой пузырь) или опорожнение **катетером** через небольшое отверстие (Indiana pouch).
2. Они больше всего различаются по **ежедневному уходу**. Лучший вариант зависит от состояния вашего здоровья и личных приоритетов — и подходит не каждому.
3. Все три используют кишечник, поэтому у всех есть слизь в моче, восстановление кишечника несколько дней и пожизненное наблюдение. Прочитайте подробный листок по выбранному варианту.